

# Od traumy relacyjnej do ucieczki przed bliskością

---

*Przemoc rodzicielska – neurobiologia alarmu – schematy – przywiązanie – autonomia – strata – konflikt – dysocjacja – decyzje rozstaniowe – proces zdrowienia*

## Streszczenie

Dokument integruje zagadnienia dotyczące wpływu przemocy psychicznej i fizycznej ze strony rodziców na funkcjonowanie osoby dorosłej, powstawania traumy relacyjnej, rozwoju niepewnych wzorców przywiązania, wczesnych schematów poznawczo-emocjonalnych oraz neurobiologicznej nadreaktywności systemu alarmowego. Następnie mechanizmy te zostają odniesione do dorosłych związków: lęku przed opuszczeniem, lęku przed pochłonięciem i kontrolą, potrzeby autonomii, odcięcia emocjonalnego podczas konfliktu oraz nagłego impulsu do wycofania lub zakończenia relacji.

Szczególne miejsce zajmuje analiza sytuacji, w której bliski przyjaciel ogranicza kontakty jeden-na-jeden z powodu wejścia kobiety w związek. Taka wiadomość może zostać odebrana nie tylko jako zmiana granicy przyjaźni, lecz jako sygnał utraty ważnej więzi, ograniczenia sieci wsparcia, zaniku autonomii albo początku podporządkowania. U osoby po przemocy, rozwodzie i bolesnym rozstaniu może to aktywować jednocześnie system przywiązania oraz system obronny. Rezultatem bywa mieszany ruch: silna potrzeba więzi i równoczesna ucieczka od zależności.

Główna teza brzmi: nagła decyzja o zerwaniu może pełnić funkcję regulacyjną. Nie zawsze jest stabilnym wnioskiem o jakości związku; czasem jest najszybszym sposobem obniżenia napięcia, odzyskania kontroli, wyprzedzenia przewidywanej straty i ochrony kruchego poczucia autonomii. Jednocześnie nie wolno automatycznie patologizować obrony niezależności. Realne próby izolowania, kontrolowania lub narzucania granic wymagają ochrony i mogą uzasadniać zakończenie relacji. Kluczowe jest odróżnienie aktualnego zagrożenia od aktywacji dawnego schematu.

## Syntetyczny łańcuch przyczynowo-skutkowy

1. **Przemoc, zawstydzanie, zaniedbanie** lub brak ochrony w dzieciństwie
2. **Trauma relacyjna:** bliskość staje się zarazem potrzebna i niebezpieczna
3. **Niedostateczny rozwój współregulacji,** mentalizacji i stabilnego poczucia Ja
4. **Nadreaktywny system alarmowy** oraz skłonność do walki, ucieczki, zamrożenia lub odcięcia

5. **Schematy:** opuszczenie, nieufność, wstyd, deprywacja, podporządkowanie i utrata siebie
6. **Niepewne przywiązanie:** wysoki lęk, wysokie unikanie lub wzorzec mieszany
7. **Dodatkowe uwrażliwienie** przez rozwód, bolesne rozstanie i utratę ważnych więzi
8. **Wyzwalacz:** zmiana granic przyjaźni przypisana istnieniu nowego związku
9. **Interpretacja:** „związek odbiera mi ludzi, wolność albo część mnie”
10. **Pobudzenie,** protest, odrętwienie, zawężenie myślenia i spadek mentalizacji
11. **Dezaktywacja więzi:** „nic nie czuję”, „muszę być sama”, „lepiej odejść”
12. **Zerwanie** jako natychmiastowa regulacja napięcia i odzyskanie sprawczości
13. **Krótkotrwała ulga,** lecz możliwe utrwalenie unikania i przekonania, że bliskość zagraża autonomii

## 1. Założenia metodologiczne i granice wnioskowania

Psychologiczne wyjaśnienie zachowania powinno mieć charakter probabilistyczny. Z historii przemocy nie wynika automatycznie konkretny styl przywiązania, a z niepewnego przywiązania nie wynika automatycznie decyzja o zerwaniu. Trauma zwiększa prawdopodobieństwo określonych sposobów reagowania, ale ostateczne zachowanie zależy również od temperamentu, zasobów, późniejszych doświadczeń, aktualnego partnera, jakości relacji, norm społecznych oraz bieżącej sytuacji.

Należy odróżnić trzy poziomy analizy. Poziom pierwszy obejmuje fakty obserwowalne: kto co powiedział, jakie granice zostały zmienione, czy partner wywierał presję, czy pojawiło się ultimatum. Poziom drugi obejmuje znaczenie nadane zdarzeniu: utrata, kontrola, odrzucenie, lojalność albo troska. Poziom trzeci obejmuje mechanizmy pośredniczące: pamięć relacyjną, schematy, styl przywiązania i reakcje neurofizjologiczne. Mieszanie tych poziomów prowadzi do nieuprawnionych wniosków.

Nie należy zakładać, że osoba „ucieka przed bliskością” wyłącznie dlatego, że chce zakończyć związek. Może również rozpoznawać autentyczną niezgodność wartości, brak zaufania, nieakceptowalne granice albo własny brak gotowości.

## 2. Przemoc rodzicielska jako źródło traumy relacyjnej

Trauma relacyjna powstaje wtedy, gdy źródłem zagrożenia, zaniedbania lub nieprzewidywalności są osoby pełniące funkcję podstawowych opiekunów. Dziecko nie może po prostu opuścić relacji. Musi jednocześnie poszukiwać bliskości i chronić się przed nią. W ten sposób konflikt między potrzebą przywiązania a potrzebą obrony zostaje wpisany w organizację emocji, ciała i obrazu siebie.

## **2.1. Przemoc psychiczna**

Przemoc psychiczna obejmuje między innymi upokarzanie, dewaluację, straszenie, odrzucanie, gaslighting, wyśmiewanie potrzeb, szantaż emocjonalny, nadmierną kontrolę oraz karanie wycofaniem miłości. Jej szczególna szkodliwość polega na tym, że atakuje nie tylko zachowanie dziecka, lecz jego poczucie wartości i prawo do przeżywania. Dziecko może dojść do wniosku, że jest wadliwe, nadmierne, egoistyczne albo niegodne troski.

W dorosłości skutkiem może być trwały wstyd, krytyczny dialog wewnętrzny, słaba klarowność tożsamości, nadmierna zależność od aprobaty albo przeciwnie – kompulsywna samowystarczalność. W relacjach osoba może nadinterpretować krytykę, unikać ujawniania potrzeb lub traktować kompromis jako zapowiedź utraty własnego Ja.

## **2.2. Przemoc fizyczna**

Przemoc fizyczna wprowadza bezpośrednie doświadczenie bólu, zagrożenia ciała oraz nagłej utraty bezpieczeństwa. Organizm uczy się, że konflikt może szybko eskalować. W dorosłości nawet podniesiony głos, napięta mimika, zablokowanie wyjścia z pomieszczenia albo presja na natychmiastową odpowiedź mogą uruchamiać reakcje obronne nieproporcjonalne do aktualnej sytuacji, ale proporcjonalne do historii doświadczeń.

## **2.3. Gdy krzywdzą oboje rodzice lub jedno nie chroni**

Szczególnie destrukcyjna jest sytuacja, w której jedno z rodziców krzywdzi, a drugie nie chroni, zaprzecza lub obwinia dziecko. Wówczas powstaje podwójny zapis: bliska osoba może być sprawcą zagrożenia, a druga bliska osoba może pozostać obojętna. W dorosłości zwiększa to ryzyko przekonań, że nie można liczyć na ochronę, że ujawnienie krzywdy nie ma sensu oraz że zależność zawsze kończy się bezradnością.

## **3. Rozwój samoregulacji i biobehawioralnej synchronii**

Niemowlę nie posiada dojrzałej zdolności samodzielnego regulowania pobudzenia. Korzysta z układu nerwowego opiekuna: tonu głosu, rytmu ruchu, mimiki, dotyku i przewidywalnej odpowiedzi. Powtarzalna współregulacja tworzy podstawę późniejszej samoregulacji. Dziecko uczy się, że pobudzenie może wzrosnąć, zostać pomieszczone i następnie opaść bez utraty relacji.

Biobehawioralna synchronia nie oznacza idealnego dopasowania. Zdrowy rozwój obejmuje cykle dostrojenia, chwilowego rozminięcia i naprawy. To właśnie doświadczenie naprawy uczy, że konflikt nie musi kończyć więzi. W rodzinie przemocowej rozminięcie często nie jest naprawiane; może prowadzić do kary, poniżenia, ciszy albo eskalacji. Dorosła osoba może więc nie posiadać wewnętrznego modelu bezpiecznego powrotu po konflikcie.

### **3.1. Oksytocyna, dopamina i nagroda społeczna**

Bliskość jest podtrzymywana między innymi przez układy nagrody i przywiązania. Oksytocyna, dopamina oraz obwody prążkowania uczestniczą w nadawaniu bodźcom społecznym wartości i w motywowaniu do kontaktu. Nie należy jednak upraszczać oksytocyny do „hormonu miłości”: jej działanie zależy od kontekstu, wcześniejszych doświadczeń i poczucia bezpieczeństwa. U osoby z traumą sygnał bliskości może jednocześnie aktywować nagrodę i alarm.

### **3.2. „Unieruchomienie bez strachu”**

Bezpieczna intymność wymaga zdolności pozostawania blisko bez konieczności walki, ucieczki lub kontroli. Można ją opisać jako stan spokojnego zatrzymania przy drugiej osobie. Jeżeli w dzieciństwie bezruch oznaczał bezradność, zamrożenie albo oczekiwanie na atak, dorosła bliskość może być somatycznie trudna. Osoba może potrzebować ruchu, dystansu, aktywności lub kontroli, aby nie czuć się uwięziona.

## **4. Neurobiologia układu alarmowego**

Przewlekłe zagrożenie w dzieciństwie wiąże się ze zmianami w funkcjonowaniu osi stresu oraz sieci mózgowych odpowiedzialnych za wykrywanie zagrożenia, uczenie kontekstowe, pamięć i kontrolę wykonawczą. W uproszczeniu obejmuje to ciało migdałowate, hipokamp, korę przedczołową i sieć istotności. Nie oznacza to nieodwracalnego „uszkodzenia”, lecz trwałe dostrojenie organizmu do środowiska, w którym szybkie wykrycie zagrożenia miało wartość adaptacyjną.

### **4.1. Hiperpobudzenie**

Hiperpobudzenie może przejawiać się przyspieszeniem myśli, napięciem mięśniowym, wzrostem tętna, drażliwością, potrzebą natychmiastowej odpowiedzi i zawężeniem uwagi. W konflikcie partnerskim osoba może przestać słyszeć niuanse, a zacząć rejestrować jedynie oznaki odrzucenia albo kontroli.

### **4.2. Zamrożenie i shut-down**

Gdy walka lub ucieczka wydają się niemożliwe, organizm może przejść w zamrożenie, odrętwienie lub zapadnięcie. Subiektywnie może to wyglądać jak pustka, brak uczuć, trudność w mówieniu, dezorientacja albo nagła pewność, że relacja nie ma znaczenia. Zewnętrznie bywa mylone z chłodem, obojętnością lub manipulacją, chociaż wewnętrznie może odpowiadać wysokiemu stresowi.

### 4.3. Zawężenie refleksji

W silnym pobudzeniu spada zdolność mentalizacji, myślenia probabilistycznego i integracji sprzecznych uczuć. Osoba łatwiej przechodzi do ocen absolutnych: „zawsze”, „nigdy”, „to koniec”, „muszę odejść”. Dopiero po obniżeniu pobudzenia może odzyskać dostęp do bardziej złożonego obrazu partnera i relacji.

## 5. Wczesne schematy i organizacja obrazu siebie

Schemat jest trwałym wzorcem interpretowania siebie, innych i relacji. Powstaje z powtarzalnych doświadczeń, a następnie selektywnie kieruje uwagą i pamięcią. Schemat nie jest świadomym przekonaniem, które można łatwo odrzucić. Może działać jak automatyczna mapa zagrożeń.

| Schemat                   | Typowe znaczenie                                                         |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Opuszczenie               | Ważni ludzie odchodzą, tracą zainteresowanie albo stają się niedostępni. |
| Nieufność i skrzywdzenie  | Bliskość zostanie wykorzystana do kontroli, upokorzenia lub zranienia.   |
| Wadliwość i wstyd         | Gdy ktoś pozna mnie naprawdę, odrzuci mnie.                              |
| Deprywacja emocjonalna    | Moje potrzeby nie zostaną zauważone ani zaspokojone.                     |
| Podporządkowanie          | Aby utrzymać relację, muszę zrezygnować z własnych potrzeb.              |
| Uwikłanie i utrata siebie | Bliskość odbiera odrębność, wolność i własne życie.                      |
| Nieustępliwe standardy    | Muszę być doskonała i niezależna, aby uniknąć krytyki lub zależności.    |

### 5.1. Introjekty

Introjekty to przejęte bez krytycznej analizy głosy i zasady opiekunów, na przykład: „nie przesadzaj”, „nikt cię nie będzie chciał”, „musisz radzić sobie sama”, „związek wymaga poświęcenia”, „nie wolno ufać”. W dorosłości mogą być przeżywane jako własna intuicja, mimo że odtwarzają dawny porządek rodzinny.

### 5.2. „Puste lustro”

Metafora pustego lustra opisuje sytuację, w której dziecko nie jest widziane jako odrębna osoba, lecz jako narzędzie regulacji potrzeb rodzica. W dorosłości może powstać fasadowe Ja oparte na osiągnięciach, aprobach, atrakcyjności albo użyteczności. Związek staje się wtedy szczególnie ryzykowny: ujawnienie potrzeb grozi utratą kontroli nad obrazem siebie.

## 6. Rana matczyzna i rana ojcowska jako ramy interpretacyjne

Pojęcia „rany matczynej” i „rany ojcowskiej” nie są formalnymi diagnozami klinicznymi. Są ramami narracyjnymi używanymi do opisu deficytów związanych z opieką, odzwierciedleniem emocjonalnym, autonomią, sprawczością i ochroną. Mogą być użyteczne, o ile nie zastępują precyzyjnych kategorii: przemocy, zaniedbania, parentyfikacji, niepewnego przywiązania i dysregulacji.

## **6.1. Rana matczyzna**

W tej ramie akcentuje się brak bezwarunkowego odzwierciedlenia, rywalizację, kontrolę, zawstydzanie kobiecej autonomii oraz podwójne wiązanie: aby być kochaną, córka ma pozostać małą i lojalną; aby się rozwijać, ryzykuje odrzucenie. W dorosłości może to prowadzić do zmniejszania siebie, perfekcjonizmu, lęku przed sukcesem i trudności w odróżnieniu troski od kontroli.

## **6.2. Rana ojcowska**

Ta rama opisuje brak ochrony, uznania, przewidywalności i wspierania sprawczości. Przemoc, uzależnienie, nieobecność lub emocjonalna niedostępność ojca mogą wpływać na poczucie, że świat nie ma stabilnej struktury, a własna siła jest niebezpieczna lub niewystarczająca. Możliwym skutkiem jest parentyfikacja, trudność w podejmowaniu decyzji albo kompulsywna potrzeba kontroli.

# **7. Style przywiązania i konflikt lęk-unikanie**

Współczesne modele przywiązania dorosłych opisują przede wszystkim dwa wymiary: lęk przywiazaniowy i unikanie bliskości. Bezpieczne funkcjonowanie nie oznacza braku potrzeb ani konfliktów, lecz zdolność łączenia zależności z autonomią i naprawiania zakłóceń.

## **7.1. Hiperaktywacja**

Przy wysokim lęku sygnał dystansu aktywuje poszukiwanie bliskości, protest, ruminację, katastrofizację i potrzebę zapewnień. Osoba może intensyfikować kontakt, testować partnera albo interpretować neutralne zachowanie jako odrzucenie.

## **7.2. Dezaktywacja**

Przy wysokim unikaniu sygnał zależności aktywuje dystansowanie, tłumienie potrzeb, devaluowanie relacji i podkreślanie samowystarczalności. Osoba może po konflikcie szybko uznać, że nie kocha, nie potrzebuje związku albo że każda zmiana oznacza utratę siebie.

## **7.3. Wzorzec lękowo-unikowy**

Wzorzec mieszany jest szczególnie niestabilny: oddalenie partnera uruchamia lęk przed porzuceniem, natomiast zbliżenie uruchamia lęk przed kontrolą. Powstaje dynamika przyciągania i odpychania. Ta sama osoba może rano domagać się bliskości, a po konflikcie pragnąć natychmiastowego zerwania. Nie jest to koniecznie świadoma gra; może odzwierciedlać przełączanie się między przeciwstawnymi strategiami obronnymi.

## 8. Autonomia, tożsamość i lęk przed pochłonięciem

Zdrowa autonomia oznacza zdolność posiadania własnych potrzeb, relacji, opinii i granic przy jednoczesnym pozostawaniu w więzi. Nie jest to izolacja ani brak wzajemnego wpływu. Każdy związek zmienia życie partnerów: wymaga uwzględniania drugiej osoby, negocjowania czasu, seksualności, lojalności i sieci społecznej. Problem zaczyna się wtedy, gdy wpływ zostaje przeżyty jako przymus, utrata podmiotowości albo zawłaszczenie.

Osoba po kontroli i przemocy może mieć bardzo niski próg reagowania na ograniczenia. Jest to częściowo adaptacyjne: pozwala szybciej zauważać izolację i manipulację. Jednocześnie może prowadzić do fałszywych alarmów, w których dobrowolna granica drugiej osoby lub zwykła konsekwencja wejścia w związek zostaje odczytana jako zamach na wolność.

**Zdrowa bliskość nie polega na braku zmian. Polega na tym, że zmiany są negocjowane, wzajemne, proporcjonalne i nie prowadzą do zaniku odrębności.**

## 9. Rozwód, bolesne rozstanie i kumulacja strat

Rozwód i bolesne rozstanie mogą wzmacniać istniejące schematy opuszczenia i nieufności. Osoba, która wcześniej została zraniona, może traktować nową więź jako obietnicę bezpieczeństwa, ale jednocześnie przewidywać jej rozpad. Pojawia się strategia prewencyjna: odejść pierwsza, zanim zależność stanie się zbyt duża.

Kolejne straty nie sumują się wyłącznie arytmetycznie. Nowy bodziec może reaktywować stare wspomnienia i uczucia, przez co aktualna strata jest przeżywana jako powtórzenie całej historii. Wiadomość przyjaciela może więc uruchomić nie tylko żal po zmianie tej konkretnej relacji, ale także echo wcześniejszych odejść, zdrad i zawodów.

## 10. Znaczenie bliskiej przyjaźni w systemie regulacyjnym

Bliski przyjaciel może pełnić kilka funkcji: źródła wsparcia, świadka historii życia, stabilizatora samooceny, towarzysza aktywności, przestrzeni autonomii oraz bezpiecznej więzi mniej obciążonej oczekiwaniami romantycznymi. Ograniczenie takiego kontaktu może być przeżywane jako utrata części systemu regulacyjnego, a nie jedynie zmiana kalendarza.

Znaczenie relacji zależy również od niejawnych aspektów: emocjonalnej wyjątkowości, wcześniejszej bliskości, potencjalnego napięcia romantycznego, roli w okresie rozvodu lub samotności. Nie można zakładać ani całkowitej neutralności, ani ukrytego romansu. Potrzebna jest analiza faktycznych granic, przejrzystości i funkcji tej relacji.

## 11. Wiadomość od przyjaciela jako wyzwacz

Treść „nie będę się z tobą spotykał sam na sam z szacunku dla twojego związku” może być interpretowana na wiele sposobów. Może oznaczać dojrzałą granicę przyjaciela, jego wła-

sne uczucia, próbę uniknięcia niejasności, lojalność wobec partnera kobiety albo wycofanie się z relacji. Psychologiczny skutek zależy od znaczenia nadanego wiadomości.

| Możliwa interpretacja    | Znaczenie psychologiczne                                              |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Neutralna granica        | Przyjaciół reguluje własne zachowanie; partner nie narzuca zakazu.    |
| Odrzucenie               | „Nie jestem już dla niego ważna, odkąd jestem w związku.”             |
| Utrata autonomii         | „Mój związek zmienia relacje, które należą do mnie.”                  |
| Początek izolacji        | „Najpierw stracę jego, potem kolejne osoby.”                          |
| Utrata części tożsamości | „Nie będę już mogła być tą samą osobą, która tańczy i chodzi w góry.” |
| Dowód kosztu bliskości   | „Każdy związek wymaga ode mnie rezygnacji z siebie.”                  |

## 12. Od bodźca do decyzji: szczegółowy model przetwarzania

- **Etap 1. Rejestracja faktu** – Nastąpiła zmiana dostępności przyjaciela.
- **Etap 2. Ocena pierwotna** – Czy jest to strata, kontrola, odrzucenie, lojalność czy nieunikniona zmiana?
- **Etap 3. Aktywacja pamięci relacyjnej** – Bieżące zdarzenie łączy się z doświadczeniami podporządkowania, utraty i braku ochrony.
- **Etap 4. Pobudzenie afektywne** – Pojawiają się złość, lęk, wstyd, żal, niesprawiedliwość lub odrętwienie.
- **Etap 5. Zawężenie poznawcze** – Maleje dostęp do alternatywnych interpretacji; rośnie myślenie zero-jedynkowe.
- **Etap 6. Strategia przywiązaniowa** – Lęk nasila protest i potrzebę odzyskania więzi; unikanie nasila dystans i potrzebę odcięcia.
- **Etap 7. Impuls działania** – Najkrótszą drogą do ulgi wydaje się zakończenie związku.
- **Etap 8. Natychmiastowa ulga** – Znosi się przeżywany przymus i odzyskuje kontrolę.
- **Etap 9. Konsekwencje długoterminowe** – Może pojawić się żal, samotność, ponowna aktywacja lęku lub powrót do relacji.

## 13. Odcięcie uczuć, zamrożenie i dysocjacja

Utrata dostępu do uczuć podczas kłótni może mieć kilka mechanizmów. Supresja polega na hamowaniu ekspresji i świadomego kontaktu z emocją. Zamrożenie jest automatyczną reakcją obronną. Dysocjacja oznacza częściowe odłączenie od doznań, emocji, pamięci albo poczucia ciągłości Ja. Zjawiska te mogą się nakładać.

W praktyce osoba może mówić: „nic nie czuję”, „nie wiem, kim dla mnie jesteś”, „muszę wyjść”, „nie mogę teraz rozmawiać”. Partner może odebrać to jako dowód braku miłości. Tymczasem dostęp do czułości może wrócić po kilku godzinach lub dniach, gdy organizm odzyska poczucie bezpieczeństwa. Zmienność uczuć zależna od pobudzenia jest ważnym sygnałem, że decyzja wymaga odroczenia.



### 13.1. Okno tolerancji

Okno tolerancji to zakres pobudzenia, w którym osoba pozostaje zdolna do czucia, myślenia i kontaktu. Powyżej pojawia się hiperaktywacja; poniżej – odrętwienie i zapadnięcie. Praca nad relacją jest możliwa głównie wewnątrz tego zakresu. Próba wymuszenia rozmowy poza nim zwiększa ryzyko eskalacji.

## 14. Zerwanie jako strategia regulacji

Decyzja o zerwaniu może mieć podwójną funkcję. Na poziomie treści oznacza ocenę, że relacja nie powinna trwać. Na poziomie regulacyjnym może natychmiast usuwać źródło napięcia, przerywać niepewność i przywracać poczucie sprawstwa. Gdy ulga pojawia się szybko, zachowanie jest wzmacniane i może powtarzać się w kolejnych konfliktach.

- wyprzedzenie przewidywanego porzucenia;
- uniknięcie zależności i podatności na zranienie;
- odzyskanie kontroli nad własnym życiem;
- obrona przed wstydem związanym z potrzebowaniem partnera;
- zatrzymanie przeciążającego konfliktu;
- ochrona ważnej przyjaźni lub sieci wsparcia;
- sprawdzenie, czy partner będzie walczył o relację – jako zachowanie protestacyjne.

Ta funkcjonalna analiza nie unieważnia decyzji. Pozwala jedynie zobaczyć, że ta sama czynność może jednocześnie wyrażać wartość, emocję i mechanizm obronny.

## 15. Alternatywne hipotezy i czynniki niepatologiczne

Rzetelna analiza wymaga konkurencyjnych hipotez. Nie każda gwałtowna reakcja jest skutkiem traumy. Możliwe są także prostsze wyjaśnienia.

- Rzeczywista niezgodność wartości dotyczących wyłączności, przyjaźni i autonomii.
- Brak gotowości do relacji wymagającej kompromisów.
- Silniejsze emocjonalne zaangażowanie w przyjaciela niż deklarowane.
- Ambiwalencja wobec partnera istniejąca przed wiadomością.
- Doświadczenie faktycznej kontroli, zazdrości lub izolowania przez partnera.
- Żaloba po utracie dotychczasowego stylu życia.
- Impulsywność, aktualny kryzys, przeciążenie lub inne trudności psychiczne niezwiązane bezpośrednio z traumą.
- Świadoma decyzja, że koszt relacji przekracza korzyści.

**Hipoteza traumatyczna nie może służyć do przekonywania osoby, że jej granice są „objawem” i dlatego powinna zostać w relacji. Takie użycie psychologii byłoby formą**

**unieważniania.****16. Jak odróżnić autonomiczną decyzję od reakcji alarmowej**

Nie istnieje pojedynczy test. Można jednak zastosować kryteria robocze oparte na stabilności, elastyczności, zgodności z wartościami i jakości przetwarzania informacji.

| Kryterium               | Pytanie diagnostyczne                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stabilność po regulacji | Czy decyzja pozostaje podobna po śnie, uspokojeniu i rozmowie bez presji?                     |
| Elastyczność            | Czy osoba potrafi rozważyć rozwiązania pośrednie bez poczucia zdrady siebie?                  |
| Oparcie w faktach       | Czy istnieją konkretne zachowania kontrolujące, czy głównie przewidywanie przyszłej kontroli? |
| Zgodność z wartościami  | Czy decyzja wspiera długoterminową wizję życia i relacji?                                     |
| Koszt i korzyść         | Czy decyzja poszerza życie, czy głównie natychmiast redukuje napięcie?                        |
| Powtarzalność wzorca    | Czy podobny impuls pojawiał się w wielu relacjach i konfliktach?                              |
| Spójność uczuć          | Czy brak uczuć jest trwały, czy występuje wyłącznie w stanie przeciążenia?                    |
| Możliwość naprawy       | Czy relacja dopuszcza przeprosiny, korektę i renegocjację granic?                             |

**17. Dynamika partnera i ryzyko eskalacji**

Reakcja partnera może osłabić albo wzmocnić system alarmowy. Nacisk, przesłuchiwanie, moralizowanie, żądanie natychmiastowej deklaracji, analizowanie jej psychiki w trakcie konfliktu i stawianie ultimatum mogą potwierdzić schemat kontroli. Z kolei całkowite wycofanie bez wyjaśnienia może potwierdzić schemat opuszczenia.

**17.1. Typowa pętla eskalacyjna**

1. Partner czuje zagrożenie relacji i domaga się jasności.
2. Kobieta doświadcza nacisku jako kontroli i dystansuje się.
3. Partner interpretuje dystans jako brak miłości i zwiększa presję.
4. Rośnie pobudzenie, pojawia się odcięcie i impuls zerwania.
5. Partner próbuje odzyskać więź jeszcze intensywniej albo odcina się odwetowo.
6. Obie strony uzyskują potwierdzenie swoich lęków: jedna – że zostanie kontrolowana, druga – że zostanie porzucona.

## 18. Warunki bezpiecznej rozmowy i negocjacji granic

Celem rozmowy nie powinno być udowodnienie, kto ma rację, lecz ustalenie faktów, potrzeb, granic i możliwych rozwiązań. Rozmowa powinna odbywać się po obniżeniu pobudzenia, bez groźby natychmiastowego rozstrzygnięcia.

- Najpierw nazwać emocje i znaczenie zdarzenia, dopiero potem negocjować zasady.
- Oddzielić decyzję przyjaciela od intencji partnera.
- Unikać języka własności: „pozwalam”, „zakazuję”, „należysz do mnie”.
- Ustalić symetryczne zasady dotyczące bliskich przyjaźni obu stron.
- Rozmawiać o funkcji spotkań, przejrzystości, granicach emocjonalnych i seksualnych.
- Uwzględnić prawo każdej osoby do własnej sieci wsparcia.
- Nie wymagać deklaracji miłości w szczycie konfliktu.
- Ustalić sposób robienia przerwy i powrotu do rozmowy.

### 18.1. Przykładowa struktura komunikatu

„Widzę, że wiadomość przyjaciela została przez Ciebie odebrana jako utrata ważnej części życia i zagrożenie dla autonomii. Nie chcę Cię izolować ani decydować za Ciebie. Jednocześnie potrzebuję, abyśmy wspólnie ustalili granice, które będą uczciwe i bezpieczne dla nas obojga. Nie musimy rozstrzygać tego w stanie silnego napięcia.”

## 19. Proces zdrowienia i neuroplastyczność

Zmiana nie polega na wyeliminowaniu potrzeb autonomii ani na zmuszaniu się do bliskości. Polega na zwiększeniu elastyczności: możliwości pozostawania w relacji bez utraty siebie, przeżywania konfliktu bez katastrofizacji oraz podejmowania decyzji po odzyskaniu dostępu do całego obrazu sytuacji.

### 19.1. Świadomość i dekonstrukcja introjektów

Pierwszym krokiem jest rozpoznanie, które przekonania są aktualną oceną, a które powtarzają głos rodzica lub dawnego partnera. Pomocne są pytania: „Czy to zdanie jest moje?”, „Kiedy pierwszy raz je usłyszałam?”, „Czy obowiązuje we wszystkich relacjach?”, „Jak brzmiałaby bardziej zrównoważona zasada?”.

### 19.2. Żałoba i odmaskowanie

Zdrowienie często wymaga uznania realnych strat: braku bezpiecznego dzieciństwa, nieotrzymanej ochrony, rozpadu małżeństwa, utraty przyjaźni lub dawnej wersji siebie. Żałoba zmniejsza potrzebę odtwarzania przeszłości w nadziei, że kolejna relacja naprawi wszystko bez świadomej pracy.

### **19.3. Reparenting**

Reparenting oznacza rozwijanie wewnętrznej funkcji opiekuńczej: nazywanie potrzeb, uspokajanie pobudzenia, ochronę granic i rezygnację z karzącego dialogu wewnętrznego. Celem nie jest infantylizacja, lecz zwiększenie zdolności do samowspółczucia i odpowiedzialnego działania.

### **19.4. Regulacja ciała**

Uziemianie, ruch, świadome rozluźnianie napięcia, orientowanie się w otoczeniu i praca z oddechem mogą pomagać wrócić do okna tolerancji. Są to metody wspomagające. Przy nasilonej traumie, dysocjacji lub PTSD nie powinny zastępować leczenia o potwierdzonej skuteczności.

### **19.5. Nowe synchronie i naprawa**

Bezpieczne relacje uczą układ nerwowy poprzez powtarzalne doświadczenia: partner respektuje przerwę, wraca do rozmowy, przyznaje się do błędu, nie karze za potrzeby i nie wykorzystuje podatności. Kluczowa jest nie idealna zgodność, lecz zdolność naprawy po rozregulowaniu.

### **19.6. Mentalizacja**

- Co czuję w ciele i jaka potrzeba została aktywowana?
- Jakie znaczenie nadałam zdarzeniu i jakie są alternatywne interpretacje?
- Co może przeżywać druga osoba, nie zakładając automatycznie złej intencji?
- Czy widzę partnera jako odrębną osobę, czy jako reprezentanta dawnych krzywd?
- Jaką decyzję podjąłabym, gdyby moje pobudzenie było o połowę mniejsze?

## **20. Interwencje terapeutyczne**

Dobór terapii zależy od dominujących objawów, bezpieczeństwa, stopnia dysocjacji i aktualnego funkcjonowania. W PTSD najlepsze poparcie mają terapie skoncentrowane na traumie, między innymi trauma-focused CBT, cognitive processing therapy, prolonged exposure, cognitive therapy for PTSD, narrative exposure therapy oraz EMDR.

### **20.1. Podejście fazowe i STAIR**

Przy nasilonej dysregulacji i chaosie interpersonalnym przydatne może być wcześniejsze rozwijanie umiejętności regulacji emocji i funkcjonowania w relacjach, a następnie przetwarzanie wspomnień traumatycznych. Stabilizacja nie powinna jednak stawać się bezterminowym unikaniem pracy z traumą.

## 20.2. Terapia schematów

Terapia schematów jest szczególnie użyteczna przy przewlekłym wstydzie, trybie odłączonego obrońcy, uległości, karzącym krytyku i powtarzaniu destrukcyjnych relacji. Pomaga rozpoznawać tryby, zaspokajać podstawowe potrzeby w dojrzały sposób oraz budować zdrowego dorosłego.

## 20.3. Terapie oparte na mentalizacji i przywiązaniu

Podejścia mentalizacyjne rozwijają zdolność utrzymywania ciekawości wobec własnego i cudzego umysłu w stanie pobudzenia. Terapie par oparte na przywiązaniu mogą wspierać naprawę więzi, ale zwykle wymagają minimalnego poziomu bezpieczeństwa i zdolności do regulacji. Nie są wskazane jako główna metoda, gdy występuje aktywna przemoc.

## 20.4. Farmakoterapia

Farmakoterapia może łagodzić współwystępujące objawy depresji, lęku i PTSD, ale nie zmienia bezpośrednio stylu przywiązania ani schematów. Decyzję podejmuje lekarz po ocenie klinicznej. Leki nie zastępują pracy nad granicami, regulacją i przetworzeniem traumy.

## 21. Praktyczny protokół analizy epizodu

1. Zapisz fakt bez interpretacji: dokładne słowa, działania i kolejność zdarzeń.
2. Nazwij automatyczne znaczenie: utrata, kontrola, odrzucenie, wstyd, niesprawiedliwość.
3. Oceń pobudzenie w skali 0–10 oraz sygnały cielesne.
4. Rozpoznaj dominującą strategię: protest, ucieczka, zamrożenie, odcięcie.
5. Zidentyfikuj aktywny schemat i możliwe wspomnienie relacyjne.
6. Odroczyć nieodwracalną decyzję, gdy pobudzenie jest wysokie, o ile nie ma aktualnego zagrożenia.
7. Po regulacji zapisz ponownie ocenę relacji i porównaj ją z oceną w kryzysie.
8. Sprawdź fakty dotyczące kontroli: kto postawił granicę, czy była presja, czy zasady są wzajemne.
9. Określ własne wartości: autonomia, lojalność, uczciwość, bezpieczeństwo, bliskość.
10. Wygeneruj co najmniej trzy rozwiązania pośrednie.
11. Przeprowadź rozmowę w uzgodnionym czasie i ogranicz ją do jednego problemu.
12. Podejmij decyzję na podstawie powtarzalnego wzorca relacji, a nie jednego afektywnego epizodu.

### 21.1. Sygnały wymagające ostrożności

– groźby, przemoc, śledzenie, kontrolowanie telefonu lub finansów;

- izolowanie od rodziny i przyjaciół;
- blokowanie wyjścia, wymuszanie rozmowy lub kontaktu;
- szantaż samobójczy albo grożenie krzywdą;
- nawracająca dysocjacja, utrata pamięci lub silne objawy PTSD;
- impulsywne decyzje o dużych konsekwencjach podejmowane w stanie skrajnego pobudzenia.

W przypadku aktywnej przemocy priorytetem jest bezpieczeństwo, a nie wspólna praca nad stylem przywiązania. Terapia par nie powinna służyć do symetryzowania odpowiedzialności sprawcy i osoby krzywdzonej.

## 22. Wnioski końcowe

Wczesna przemoc może przekształcić bliskość w bodziec ambiwalentny: upragniony i zarazem zagrażający. Brak bezpiecznej współregulacji utrudnia wyciszenie pobudzenia, schematy nadają konfliktom znaczenie opuszczenia lub kontroli, a niepewne przywiązanie uruchamia naprzemiennie protest i wycofanie. Rozwód oraz bolesne straty mogą dodatkowo obniżać próg alarmowy.

Wiadomość przyjaciela o ograniczeniu spotkań może stać się punktem zapalnym, ponieważ łączy realną zmianę więzi z symbolicznym pytaniem o koszt nowego związku. Dla osoby szczególnie wrażliwej na utratę autonomii może ona znaczyć: „związek zabiera mi część życia”. W stanie pobudzenia pojawia się zawężenie perspektywy, odcięcie uczuć i impuls zakończenia relacji. Zerwanie może przynieść natychmiastową ulgę, lecz nie zawsze odpowiada stabilnym wartościom i trwałej ocenie partnera.

Najważniejsze rozróżnienie przebiega między reakcją na realną kontrolę, a reakcją na pamięć kontroli. Zdrowa decyzja jest zwykle bardziej stabilna po regulacji, oparta na faktach, elastyczna i zgodna z długoterminowymi wartościami. Proces zdrowienia wymaga bezpieczeństwa, pracy z ciałem i emocjami, rozpoznania schematów, przetworzenia traumy, odbudowy autonomii oraz doświadczenia relacji, w której konflikt może zostać naprawiony bez utraty siebie.